

Kapitel 1

DANSKERNES SUNDHEDSTILSTAND

Knud Juel og Morten Grønbæk

DØDELIGHED OG SYGELIGHED

En befolknings sundhedstilstand kan beskrives ved en lang række forskellige mål. Det kan fx være middellevetid, dødelighed, årsagsspecifik dødelighed og sygelighed. Målene fås fra forskellige registre, og i Danmark findes unikke registre (CPR-registret, Dødsårsagsregistret, Cancerregistret, Landspatientregisteret (LPR) og mange andre), der beskriver dødelighed og sygelighed i befolkningen.

Middellevetid

En meget anvendt indikator for livslængde er middellevetiden. Middellevetiden er det antal år, en nyfødt kan forventes at leve, hvis barnet bliver født det pågældende år i det pågældende land. Middellevetiden i Danmark er næsten fordoblet siden midten af 1800-tallet. I 2017 var middellevetiden 79 år for mænd og 83 år for kvinder. Øgningen i middellevetiden er sket lidt forskelligt for mænd og kvinder. Middellevetiden for kvinder har hele tiden ligget højere end mænds, men hvor forskellen på mænd og kvinder i Danmark i 1950'erne var tre år og i 1980'erne seks år, er den nu reduceret til fire år (Fig. 1.1).

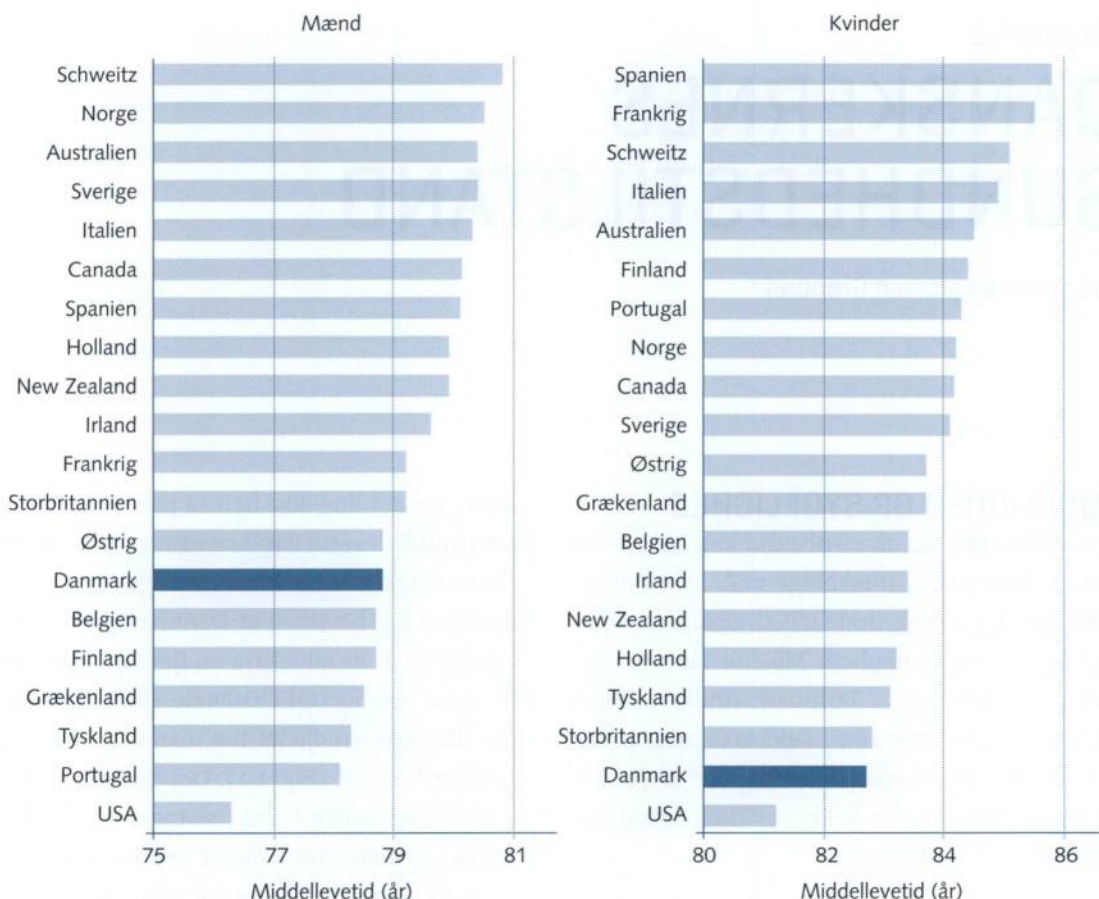
Mange faktorer har spillet ind på øgningen i middellevetiden i Danmark. En vigtig komponent er spædbarnsdødeligheden, der alene inden for de sidste 50 år er faldet meget. For 50 år siden døde 4 % af børnene inden for det første leveår, mens dødeligheden blandt spædbørn nu er under 0,5 %. Isoleret set er det imponerende med så stærkt stigende middellevetider i Danmark. Sammenligner man med nærliggende

lande, ser det dog ikke helt så pænt ud; stigningen i middellevetid har ikke været nær så kraftig i Danmark som i fx Norge, Sverige og især Finland. Det har bevirket, at Danmark i løbet af de seneste 50 år er faldet fra en fjerdeplads blandt 20 store vestlige OECD-lande til nu at ligge i den dårligste tredjedel for mænd og næstdårligst for kvinder (Fig. 1.2). Det bemærkes igen, at middellevetiden i praktisk taget alle lande er betydeligt højere for kvinder end for mænd.

Det er især de tobaks- og alkoholrelaterede lidelser, der har en dramatisk effekt på den samlede middellevetid. Det kan fx ses i en undersøgelse fra årtusindskiftet, hvor middellevetidstabt er sammenlignet med Sverige (Tabel 1.1). For mænd var forskellen i middellevetid 2,80 år, hvoraf 2,47 år eller 88 % kunne relateres til tobak og alkohol. På trods af at undersøgelsen



Figur 1.1. Middellevetiden i Danmark for mænd og kvinder, 1845-2015 (1845 angiver perioden 1840-49, ..., 2005 perioden 2000-09 og 2015 perioden 2010-17).



Figur 1.2. Middellevetiden i 20 vestlige OECD-lande for mænd og kvinder, 2015.

Tabel 1.1. Tab i middellevetid angivet i år i Danmark sammenlignet med Sverige 1997-2001. Kilde: Juel K. Middellevetid og dødelighed i Danmark sammenlignet med Sverige. Ugeskr Læger 2008; 170: 2423-7.

	Mænd år	Kvinder år	Mænd % af total	Kvinder % af total
1. Alle dødsårsager	2,80	3,00	100	100
2. Alkohol i alt	0,63	0,30	23	10
3. Alle tobaksrelaterede	1,99	1,98	71	66
4. Alle tobaksrelaterede justeret for alkohol	1,84	1,91	66	64
5. Alkohol og tobak i alt (2 + 4)	2,47	2,21	88	74

er relativt gammel, har vi grund til at antage, at den stadig gælder.

Dødelighed

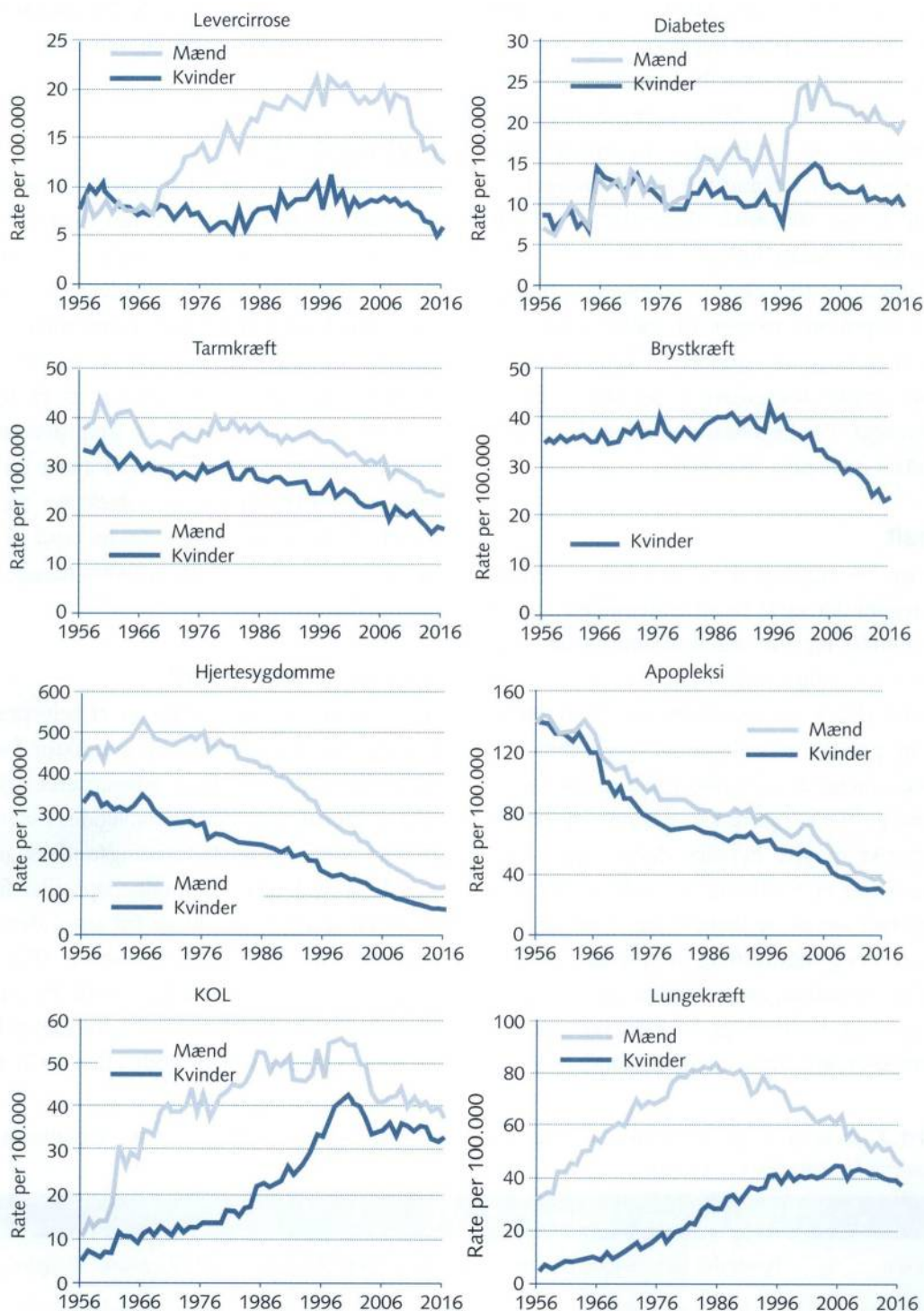
Dødelighed er et groft mål for befolkningens sundhedstilstand og opgøres i hyppighed, oftest antal dødsfald per 1.000 personer per år. Mere

detaljeret og oplysende er dødelighed af forskellige årsager og i forskellige aldersgrupper. Det er især dødeligheden blandt midaldrende danskere, der trækker vores middellevetid ned, når man sammenligner med vores nabolande.

Der er stor forskel på dødeligheden nu og for 60 år siden for lungekræft, kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) og diabetes (Fig. 1.3). Niveaulet er betydeligt højere nu. Dødeligheden af tarmkræft og brystkræft har i mange år ligget på et stabilt niveau, men der ses faldende dødelig-

hed de seneste 20 år. Den mest positive udvikling ses for hjertesygdomme og apopleksi (hjerneblødning/blodprop). Årsagerne til det store fald er både forebyggelse og bedre behandling.



Figur 1.3. Dødeligheden for udvalgte dødsårsager for mænd og kvinder i Danmark, 1956-2016. Aldersstandardiserede rater per 100.000 (raterne er uafhængige af aldersforskelle i perioden).

Sygdomme og sygdomsbyrde

Sygdomsbyrden for de enkelte sygdomme afhænger særdeles meget af, hvilket mål der anvendes. Det fremgår af Tabel 1.2, hvor de tre hyppigste sygdomme for mænd og kvinder er angivet for fire forskellige mål. For dødsfald er iskæmisk hjertesygdom og apopleksi to af de hyppigste sygdomme for både mænd og kvinder. For mænd er yderligere lungekræft blandt de hyppigste og for kvinder Alzheimers sygdom. Tages der udgangspunkt i indlæggelser, genfindes kun iskæmisk hjertesygdom blandt de hyppigste. Nedre luftvejsinfektioner, som er en hyppig årsag til, at børn indlægges, er blandt de tre hyppigste årsager til indlæggelse. For skadestuebesøg, som omfatter både somatiske og psykiatriske skadestuer, fylder skizofreni og angst meget. For lægebesøg er muskel- og skeletlidelser de hyppigste årsager.

Globalt

Ser man på sygelighed og dødelighed verden over, tegner der sig et noget andet billede. Først og fremmest lignede sygeligheden og dødeligheden i udviklingslande indtil for 10-15 år siden mere det, vi så i Danmark for 100 år siden. Det var præget af smitsomme sygdomme og traumer, mens de kroniske (ikke-smitsomme) sygdomme som hjerte-kar-sygdom og kræft var relativt mindre hyppige dødsårsager. I de senere årtier er udviklingen vendt. I takt med den globalt set bedre behandling af infektionssygdomme og mindskning af spædbarnsdødeligheden, spredningen af vestlige spise- og rygevaner samt den demografiske udvikling ligner dødsårsagsmønsteret i udviklingslandene mere

og mere vores. For første gang i verdenshistorien bor der flere mennesker i byer end på landet, er der flere overvægtige end undervægtige, flere dødsfald blandt voksne end blandt børn og en højere forekomst af kroniske sygdomme (*non-communicable diseases, NCD*) end af smitsomme sygdomme i udviklingslandene.

LIVSKVALITET

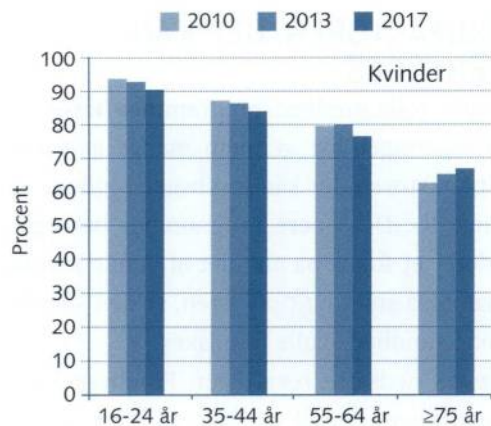
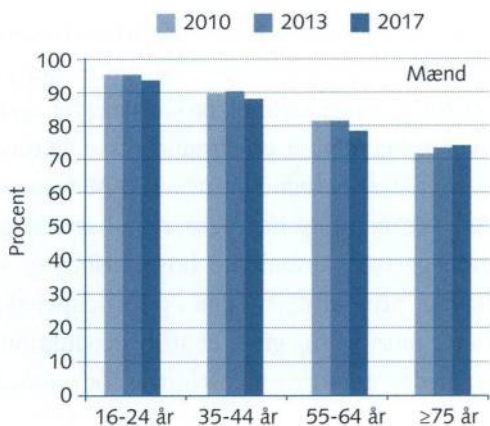
To centrale begreber til at vurdere livskvalitet er selvvurderet helbred, og om man føler sig nervøs eller stresset. Disse oplysninger findes ikke i registre på samme måde som mål for dødelighed, men indsamles i forbindelse med befolkningsundersøgelser. Siden de nationale sundhedsprofiler blev indført i 2010, er der regelmæssigt indsamlet data fra stikprøver af den voksne danske befolkning, hvad angår en lang række livsstilsfaktorer og subjektive mål for sundhed. Disse oplysninger findes også på regionalt og kommunalt niveau (www.danskernesundhed.dk).

Selvvurderet helbred

Selvvurderet helbredsstatus er et selvstændigt begreb, der er en uafhængig prædiktør for dødelighed. WHO anbefaler selvvurderet helbred som et globalt mål, der kan anvendes i såvel nationale som lokale befolkningsundersøgelser. Fra de landsdækkende sundhedsprofiler findes sammenlignelige tal tilbage fra 2010, der giver mulighed for at se på udviklingen (Fig. 1.4). Ifølge den nationale sundhedsprofil fra 2017 angiver 83 % af befolkningen, at deres eget helbred er fremragende, vældig godt eller godt, mens

Tabel 1.2. De tre hyppigste sygdomme for mænd og kvinder for dødsfald, indlæggelser, skadestuebesøg og lægebesøg. M = mænd, K = kvinder.

Mål	De tre hyppigste sygdomme
Dødsfald	Iskæmisk hjertesygdom (M&K), apopleksi (M&K), lungekræft (M), Alzheimers sygdom (K)
Indlæggelser	Nedre luftvejsinfektioner (M&K), iskæmisk hjertesygdom (M&K), misbrug (M), artrose (K)
Skadestuebesøg	Skizofreni (M&K), angst (M&K), misbrug (M), depression (K)
Lægebesøg	Lænderygmerter (M&K), nakkesmerter (M&K), artrose (M&K)



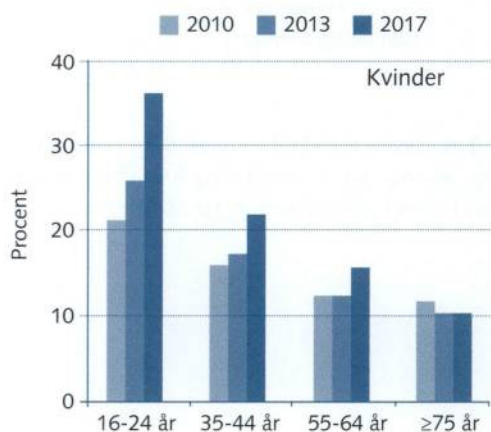
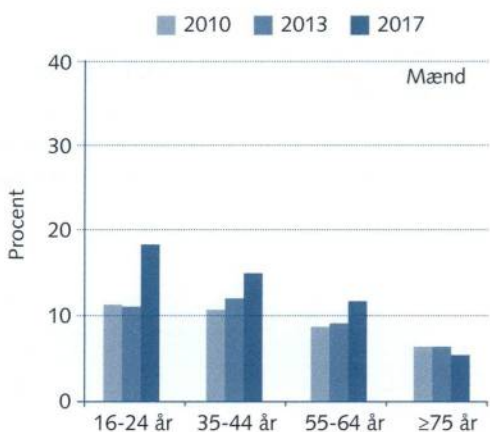
Figur 1.4. Selvvurderet helbred (fremragende, vældig godt eller godt) blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Udviklingen 2010-2017.

17 % vurderede deres eget helbred som mindre godt eller dårligt. Andelen af personer med godt selvvurderet helbred er med tiden steget i de ældre aldersgrupper, men falder med stigende alder (Fig. 1.4.). I den yngste aldersgruppe er andelen med godt selvvurderet helbred svagt aftagende med tiden.

Nervøs eller stresset

Stress udgør et stigende folkesundhedsproblem og kan beskrives som en kortere- eller længerevarende tilstand af anspændthed og ulyst. Oplevelsen af stress er subjektiv og afhænger af bl.a. egne ressourcer og af, hvordan man individuelt reagerer på og håndterer stressen. Længereva-

rende stress er en risikofaktor for adskillige sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdom og depression. I de nationale sundhedsprofiler bliver der spurgt til oplevelsen af belastende eller stressende situationer inden for den seneste måned. Spørgsmålet går på, hvor ofte man føler sig nervøs eller stresset. Der er store forskelle i den andel, der angiver, at de ofte føler sig nervøse eller stressede (Fig. 1.5). Forskellene afhænger af årstal, alder og køn. Kvinder angiver konsekvent oftere at føle sig nervøse eller stressede, og for både mænd og kvinder falder andelen med stigende alder. På nær blandt de ældste ses en stigende andel med tiden. Niveau og udvikling er specielt bekymrende for unge kvinder.



Figur 1.5. Ofte nervøs eller stresset (inden for den seneste måned) blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Udviklingen 2010-2017.

RISIKOFAKTORER, DER KAN FOREBYGGES

Skiftende folkesundhedsprogrammer fra skiftende regeringer har gennem mange år fokuseret på faktorer, der kan forebygge sygdom og forlænge liv. De senere programmer har også inkluderet et fokus på antallet af sunde leveår. Det har også stået højt på listen, at den sociale ulighed i sundhed skulle mindskes.

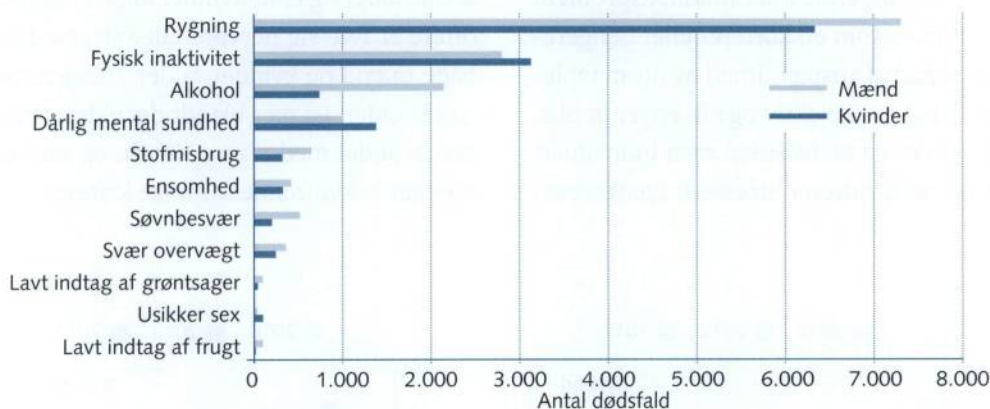
I 2008 nedsatte regeringen Forebyggelseskommissionen, der fik til opgave at analysere Danmarks udfordringer på folkesundhedsområdet samt at komme med forslag til, hvilke områder der fremover bør prioriteres. Forebyggelseskommissionen udarbejdede 52 forslag til en forebyggende indsats mod bl.a. usund kost, rygning, storforbrug af alkohol og fysisk inaktivitet.

Det er fuldt berettiget, at der er megen fokus på de såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), når det gælder om at øge middellevetiden. Således er rygning stadig topscorer, når det gælder om at gøre indhug i den danske middellevetid, og de øvrige KRAM-fak-

torer har også stor betydning for den samlede middellevetid (Fig. 1.6). I Fig. 1.6 er der justeret for rygning, alkohol, fysisk aktivitet og BMI, hvilket betyder, at effekten af disse faktorer er fjernet fra beregningerne. KRAM-faktorerne, og især rygning, har også stor betydning for indlæggelser, ambulante hospitalsbesøg, sygefravær, brug af egen læge og førtidspensioner. Dette merforbrug giver et stort produktionstab og medfører store omkostninger for samfundet.

FOKUS PÅ UDVALGTE SYGDOMME

Formålet med denne bog er at beskrive de sygdomme, der har størst betydning i Danmark både for det enkelte individ og for samfundet som helhed. I de efterfølgende kapitler er de sygdomme, som er mest betydningsfulde for de vigtigste mål for en befolknings sundhedstilstand, nemlig forekomst, livslængde og livskvalitet, derfor udvalgt. En del af disse sygdomme har gode forebyggelsesmuligheder, og disse muligheder vil da tillige være beskrevet.



Figur 1.6. Ekstra dødsfald for mænd og kvinder i Danmark relateret til forskellige risikofaktorer. Justeret for rygning, alkohol, fysisk aktivitet og BMI (for risikofaktoren rygning er der justeret for alkohol, fysisk aktivitet og BMI osv.). Årligt gennemsnit 2010-2012.

Kapitel 2

PATIENTENS VEJ Gennem SUNDHEDSVÆSNET

Anneli Sandbæk og Mette Kjær

Det danske sundhedsvæsen er opbygget med det sigte at give en sammenhængende og optimal diagnostik og behandling med lige adgang for alle.

Sundhedsvæsenet, som det fremstår i dag, og patientens vej gennem det vil i det følgende blive beskrevet med udgangspunkt i tre personer (cases). I den ene case beskrives forløbet hos en kvinde, der har fået konstateret en knude i brystet ved en mammografi, som hun blev indkaldt til ved en rutineundersøgelse. I den anden case beskrives et barn, der har fået ondt i ørerne, og i den tredje beskrives en mand på 55 år, der akut får smerter i brystet, og som har haft diabetes i flere år. De sygdomsmæssige fakta vil ikke blive gennemgået i dette kapitel. Her henvises til relevante kapitler i bogen. Efter de tre cases beskrives hovedaktørerne i det danske sundhedsvæsen.

KNUDE I BRYSTET ...

I Danmark bliver alle kvinder i alderen 50 til 69 år hvert andet år inviteret til en mammografiscreening. Ved en sådan screening blev der hos Birgit på 51 år opdaget en knude i brystet. Mammografiscreeningen blev foretaget på en mammografiklinik oprettet til formålet. Birgit skal videreundersøges, og det foregår på en af regionens røntgenafdelinger med kapacitet til den slags undersøgelser. Her foretages udover mammografien en lægeundersøgelse samt en ultralydsundersøgelse, og evt. udtages en vævsprøve (biopsi). Langt de fleste af de knu-

der, der opdages ved mammografi, er benigne (godartede). Birgit fik efter 10 dage svar fra klinikken med oplysning om, at knuden var benign. Birgits praktiserende læge fik en epikrise (udskrivesbrev med undersøgelsesresultater). Hvis knuden havde været malign (ondartet), ville Birgit være blevet inkluderet i et kræftpakkeforløb, der er etableret i alle regioner for at sikre en hurtig udredning og behandling. Hun ville i denne situation blive tilknyttet en af de hospitalsafdelinger i regionen, der har den funktion at behandle brystkræft. Behandling af brystkræft tager flere måneder, og i denne periode vil patientens egen alment praktiserende læge få én eller flere epikriser tilsendt med det formål at blive holdt opdateret. Kræftafdelingen har ansvaret for behandlingen og efterfølgende kontrol i en kortere periode, hvorefter egen læge tager over. I tilfælde af at brystkræften ikke helbredes, vil egen læge oftest være tovholder i den sidste fase med henblik på at yde palliativ (lindrende) omsorg, evt. i samarbejde med en palliativ enhed.

ONDT I ØRERNE ...

Toårige Kasper har fået ondt i ørerne og vil ikke sove. Forældrene ringer til vagtlægen, da den praktiserende læge har lukket kl. 16. Vagtlægen konstaterer ved en konsultation i lægevagten, at Kasper rigtignok har væske i mellemørerne samt feber, og at det kan forklare hans smerter og utilpashed. Forældrene bliver rådet til at give Kasper smertestillende og febernedsættende

medicin (paracetamol) og at søge egen læge, hvis generne mod forventning ikke svinder i løbet af et par dage. Næste dag har Kasper stadig feber og angiver, at han har ondt i ørerne, så egen læge kontaktes, og egen læge bekræfter vagtlægens diagnose. Det aftales, at Kasper, når han er feberfri, skal komme for at få målt trykket i mellemørerne. Denne undersøgelse viser, at Kasper har væske i begge mellemører, og en ny kontrol aftales efter tre måneder. Da der ved denne undersøgelse stadig er væske i mellemørerne, henvises Kasper til en privatpraktiserende speciallæge i øre-næse-halssygdomme. Øre-næse-halslægen vælger at se tiden an i yderligere tre måneder, men da der ikke er ændringer i tilstanden, anlægges dræn. Det foregår i øre-næse-halslægens praksis med hjælp af en anæstesilæge, der bedøver Kasper. Han følges et par gange hos øre-næse-halslægen, hvorefter egen læge tager over. Da Kasper bliver fire år, har han haft flere tilfælde med lungebetændelse og tendens til hoste. Han henvises derfor til børneafdelingen med henblik på udredning for astma. Hvis Kasper havde været lidt ældre, kunne egen læge have udredt ham for astma. Egen læge ser igen Kasper til femårs-børneundersøgelsen.

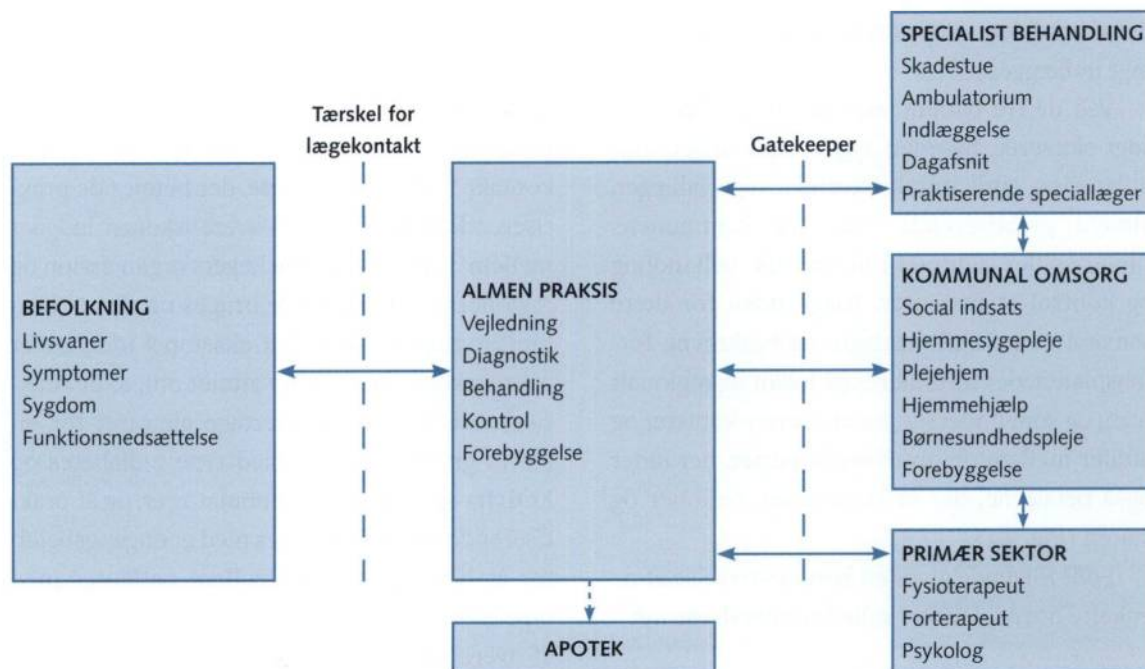
DIABETES OG ONDT I BRYSTET ...

Torsten på 55 år har i fire år haft type 2-diabetes, som han er velbehandlet for. Egen læge stillede diagnosen, og Torsten er i relevant behandling og kontrolleres hver tredje måned hos egen læge. For to år siden var Torsten med på diabetesskolen – et tilbud ved det lokale diabetesambulatorium. En aften i april får han det skidt, har lidt trykken for brystet og går tidligt i seng. Næste morgen er det lidt bedre, og han tager på arbejde i it-firmaet, hvor han er projektleder. Ved 11-tiden bliver symptomerne forværret, og der er nu reelle smerter i brystkassen. Torsten ringer til egen læge, der allerede ved denne samtale mistænker en blodprop i hjertet. HjerTEAM-bulancen rekvireres, Torsten bliver undersøgt af paramedicinen (en ambulanceredder med videreuddannelse), og der bliver digitalt sendt

hertekardiogram og oplysninger til den regionale højspecialiserede hjerteafdeling. Da der er tegn på blodprop i hjertet, hvilket skal behandles på en højspecialiseret hjerteafdeling, køres Torsten direkte dertil frem for at køre forbi det nærmeste hospital. På hjerteafdelingen modtages han af et hold specialister, der i løbet af kort tid har stillet diagnosen og behandlet ham. Han kommer sig og kan udskrives efter få dage. I efterforløbet er han tilknyttet det hjerterehabiliteringsprogram, der findes i regionen, og som bl.a. sikrer, at Torsten informeres om og uddannes i livsstilsændringer samt om den medicin/behandling, han efterfølgende skal have. Kontakt til egen læge etableres også i dette forløb. Seks måneder efter blodproppen afsluttes Torsten som patient på hjerteafdelingen. Af egen læge henvises han til det kommunale rehabiliteringsforløb, samtidig med at han fortsætter med at gå til kontrol for sin diabetes og hjertesygdom hos egen læge.

Hvad illustrerer disse patientforløb?

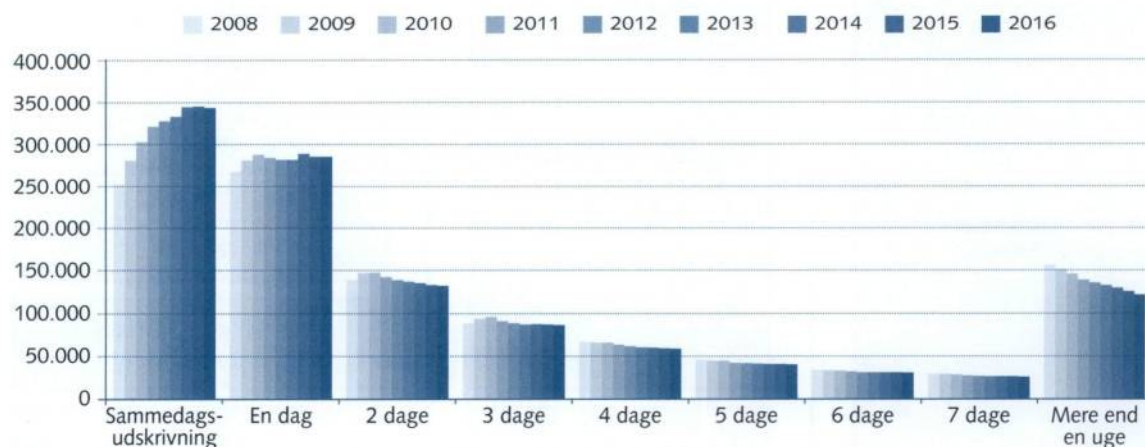
Det danske sundhedsvæsen er opbygget efter det princip, at de hyppigste sygdomme og tilstande skal kunne diagnosticeres og behandles tættest muligt på patienten, dvs. lokalt, mens den specialiserede behandling skal foregå på højt specialiserede sygehuse (Fig. 2.1). Som følge af den udvikling, der til stadighed sker i diagnostiske principper og behandlingsmuligheder ved såvel sjældne sygdomme som de større folkesygdomme, sker der også en løbende ændring af, hvem der har ansvaret for behandlingen. Et eksempel herpå er håndteringen af type 2-diabetes. For år tilbage blev mere eller mindre al behandling med insulin hos diabetikere varetaget af læger tilknyttet ambulatorier ved endokrinologiske sygehusafdelinger. For nuværende har praktiserende læger overtaget langt hovedparten af denne funktion. Denne ændring har været nødvendig pga. det kraftigt øgede antal personer med diabetes og har kunnet gennemføres på baggrund af videreuddannelse af lægerne og ansættelse af sygeplejersker i almen praksis. Igennem de senere år er antallet



Figur 2.1. Almen praksis som visitor i det danske sundhedsvæsen (fra Vedsted m.fl. 2005).

af indlæggelsesdage per diagnose faldet væsentligt, og samtidig er produktiviteten steget (Fig. 2.2). Patienterne behandles i dag oftere ved endagsindlæggelser og ambulatoriebesøg. Man har ved disse omfordelinger fået meget mere behandling for pengene. Endnu en væsentlig ændring i sundhedsvæsenet indførtes med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne fik overført ansvaret for såvel forebyggelse som rehabilitering. Opgaven med denne kolossale

ændring er stadig ikke helt gennemført, men de fleste kommuner har bl.a. ved at samarbejde med andre kommuner fået etableret generelle og specialiserede rehabiliteringsforløb. Et eksempel på et specialiseret rehabiliteringsforløb er forløbet for personer med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), der har mange kontakter til både praktiserende læger og hospitaler. Et vel-fungerende tilbud i kommunen kan overtage en



Figur 2.2. Udvikling i antal indlæggelser fordelt efter deres varighed 2008-2016.

Note: Antal indlæggelser afsluttet i de enkelte år fordelt efter indlæggelsens varighed (uanset diagnose og alder).

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

del af arbejdet, således at patienten ikke så hyppigt indlægges.

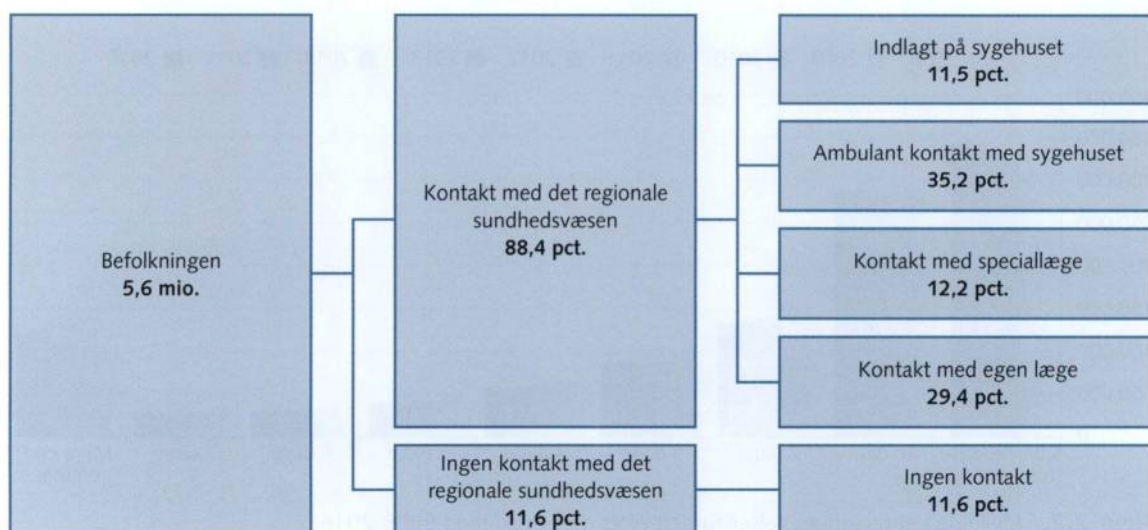
Ved de tre patientcases ovenfor er det forsøgt skitseret, hvordan sygehusafdelinger, ambulatorier, privatpraktiserende speciallæger, alment praktiserende læger og kommunens tilbud spiller sammen i diagnostik, behandling og kontrol af patienter. Baggrunden for dette samspil er nøje tilrettelagte og beskrevne forløbsplaner, der formuleres på lokalt og regionalt plan, og som understøttes af overenskomster og aftaler mellem de involverede parter, herunder også betalerne, der er kommuner, regioner og staten (Fig. 2.3).

I det følgende gives en kort beskrivelse af de enkelte hovedaktørers rolle i sundhedsvæsenet.

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER

En udredning starter oftest, som det også fremgår af de beskrevne cases, hos patientens egen læge. At den praktiserende læge er gatekeeper for det meste af det øvrige sundhedsvæsen, er et valg, der bunder i, at den enkelte borger i princippet ikke kender årsagen til et givet symptom. Det er den praktiserende læge, som kan skelne mellem de borgere, der skal behandles, og dem, der ikke skal behandles, og som skal henvises – eller ikke henvises – videre i systemet. Praktise-

rende læger ejer oftest selv deres forretning. De bliver honoreret for deres arbejde dels ved et basis honorar, der afhænger af antallet af tilmeldte patienter, dels ved honorarer for hver enkelt kontakt. Det er regionerne, der betaler de praktiserende læger ifølge en overenskomst indgået mellem de praktiserende lægers organisation og regionerne. Denne aftale bruges også som kvalitetsstyringsredskab. For eksempel indeholder overenskomsten fra 2017 aftaler om, at de praktiserende læger skal overtage ansvaret for en større gruppe borgere med type 2-diabetes og KOL fra specialiserede ambulatorier, og at praktiserende læger honoreres med et engangsbeløb for at behandle og kontrollere patienter med type 2-diabetes og KOL. Denne nylige ændring af overenskomsten er primært drevet af behovet for, at personer med velreguleret diabetes og KOL ikke fylder hospitalsambulatorierne, og at en udflytning af flere patienter ikke kommer til at udløse en kraftig udgiftsøgning. Nogle praktiserende læger sidder i solopraksis med eget personale, mens andre praktiserende læger er gået sammen i lægehuse, der så rummer flere læger og ofte et tværfagligt personale. Solopraksis har traditionelt været at finde i storbyer, men er på kraftig retur med de stigende krav til praksis om at varetage flere og mere tværfaglige opgaver. Hvis de praktiserende læger ikke selv kan vare-



Figur 2.3. Befolkningens kontakt til det regionale sundhedsvæsen fordelt efter mest specialiserede kontakt, 2015 (%).

tage diagnosticering, behandling eller kontrol af patienterne, kan de henvise til privatpraktiserende speciallæger eller til hospitalsafdelinger med speciallæger (afdelings- og overlæger). Antallet af alment praktiserende læger reguleres af regionerne ved hjælp af et antal ydernumre. Således kan en læge kun åbne en praksis, når der er erhvervet et ydernummer.

Vagtlægeordningen er stadig primært varetaget af de praktiserende læger – dog med regionale forskelle. Således er ”1813”, som er en uafhængig institution, etableret i Region Hovedstaden. I ”1813” kan telefon-visitatoren have en anden faglig baggrund end lægelig.

PRIVATPRAKTISERENDE SPECIALLÆGER

Privatpraktiserende speciallæger ejer deres egen praksis og betales af regionerne for patientbehandling. Nogle af de almindeligste specialer, der har privatpraktiserende speciallæger, er røntgendiagnostik, øre-næse-halssygdomme, hudsygdomme og øjensygdomme. Der findes dog også speciallægepraksis i mange andre specialer, fx i kirurgi, hvor der foretages mindre operationer, fx fjernelse af åreknuder. Honoreringen af de privatpraktiserende speciallæger er tilsvarende de praktiserende lægers ifølge en overenskomst forhandlet mellem de privatpraktiserende lægers organisation og regionerne. Antallet af privatpraktiserende speciallæger reguleres af regionerne på samme vis som beskrevet for de alment praktiserende læger ved hjælp af et antal ydernumre.

OFFENTLIGE HOSPITALER

Hospitalets afdelinger tages i brug i akutte situationer, og når det er nødvendigt med yderligere udredning, afklaring af sjældnere diagnoser og kompliceret behandling. Der findes i dag 39 forskellige specialer (Tabel 2.1), hvor de fleste har behandlingsafsnit på de største sygehuse – universitetshospitalerne. På de lidt mindre sygehuse findes kun et udsnit af specialerne. Der er på

Tabel 2.1. Specialer i Danmark, juni 2018 (IM: intern medicin).

Akut medicin	Klinisk farmakologi
Almen medicin	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Anæstesiologi	Klinisk genetik
Arbejdsmedicin	Klinisk immunologi
Børne- og ungdomspsykiatri	Klinisk mikrobiologi
Dermatovenerologi	Klinisk onkologi
Diagnostisk radiologi	Neurokirurgi
Gynækologi og obstetrik	Neurologi
IM: endokrinologi	Oftalmologi
IM: gastroenterologi og hepatologi	Ortopædisk kirurgi
IM: geriatri	Ortorinolaryngologi
IM: hæmatologi	Patologisk anatomi og cytologi
IM: infektionsmedicin	Plastikkirurgi
IM: kardiologi	Psykiatri
IM: lungesygdomme	Pædiatri
IM: nefrologi	Retsmedicin
IM: reumatologi	Samfundsmedicin
Karkirurgi	Thoraxkirurgi
Kirurgi	Urologi
Klinisk Biokemi	

større sygehuse etableret fælles akutmodtageenheder (FAM), der modtager alle patienter uanset sygdom. Tidligere blev patienten indlagt på en sygdomsspecifik afdeling, fx neurologisk afdeling, hvis der var mistanke om blodprop i hjernen. I forbindelse med oprettelse af FAM-enhederne er der for nyligt oprettet et nyt lægeligt speciale i akut medicin. En ordning med fælles modtageafdelinger skal sikre, at patienten behandles så kvalificeret som muligt så hurtigt som muligt. Patienterne kan udskrives direkte til hjemmet fra FAM eller overflyttes til en specialafdeling, når behovet herfor er til stede.

På hospitalerne findes skadestuer/akutklinikker, der i nogle regioner er døgnåbne (dog skal der altid ringes i forvejen) for direkte henvendelse fra borgerne, mens henvendelse i andre regioner kræver henvisning fra vagtlæge/visitator. Der er på hospitalerne også døgnåbne sengeafdelinger til indlagte patienter, og til de meget svært akut syge findes intensivafdelinger. Til patienter, der er under udredning for en sygdom eller i et kontrolforløb, men som ikke har brug for behandling hele døgnet, findes der ambulatorier og daghospitalet. Her tilses patienterne af højt specialiserede læger. I udredningen af en sygdom kan der være brug for specialiserede undersøgelser, fx en ultralydsscanning af maven, som foretages på røntgenafdelingen af en røntgenlæge, eller blodprøveanalyser foretaget af en bioanalytiker fra den klinisk-biokemiske afdeling. På hospitalet foregår kommunikationen, herunder henvisninger og rekvirering af undersøgelser, altomvejende ved hjælp af den elektroniske journal.

PRIVATHOSPITALER OG PRIVATE KLINIKKER

Der findes en del private hospitaler og klinikker, som varetager udvalgte dele af de funktioner, der også varetages på de offentlige hospitaler. Der findes dog ikke i Danmark et privat hospitalsvæsen, som kan tilbyde alle behandlinger.

For eksempel vil en patient, der er opereret på en privat klinik, og hvor der efterfølgende tilstøder alvorlige komplikationer, skulle overføres til et offentligt hospital. Private klinikker og hospitaler betales af patienterne selv, af sundhedsforsikringer eller via aftaler med regionerne, der fx ikke har kapacitet til at behandle visse patientgrupper inden for de behandlingsgarantier, som Sundhedsstyrelsen fastlægger.

ANDRE BEHANDLERE

Efter henvisning fra alment praktiserende læge kan man få tilskud fra regionen eller kommunen til behandling hos en række forskellige behandlere, der typisk har deres egen praksis/forretning, herunder fysioterapeuter, psykologer, diætister og fodterapeuter. Generelt for disse behandlingsmuligheder gælder, at der er henvisningskriterier, som er defineret af de samarbejdende parter inden for det specifikke fagområde. For eksempel kan henvisning til psykolog komme på tale, når en person har en let til moderat depression og er ældre end 18 år. En nyligt indgået aftale, som dog er en forsøgsordning (varende til december 2021), vedrører gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 med angst og depression (let til moderat). Kriterierne for, hvilke patientgrupper der kan henvises, kan ændres over tid, fx i forbindelse med nye overenskomster.